



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Відділення променевої діагностики Радіологічний звіт

Пацієнт Жерліцина Анастасія Станіславівна
ID 110889

Дата народження 25.04.1976

Дата дослідження 08.07.2026

Дослідження ретроспективний аналіз наданих обстежень

Клінічні дані/завдання дослідження:

Код за МКХ-10:C16.9 - Злоякісне новоутворення шлунка, не уточнене. Діагноз: Лейоміосаркома тіла матки, T2NxM1, вторинне ураження печінки, брюшини. Стан після 4-х циклів хіміотерапії за протоколом Гемцитабін + Доцетаксел + Авастин з прогресією хвороби в печінці (за даними КТ, МРТ від 10/2022). Виявлена мутація C-KIT, MET (ONCOMINE). Стан після лікування Пазопанібом (05-12/01/2023) з розвитком синдрому задньої зворотної енцефалопатії та позитивною динамікою за даними КТ. 01/2023 - повторна біопсія печінки. ПГД - метастаз лейоміосаркоми матки. Стан після 3-х циклів хіміотерапії за протоколом Трабектидін з негативною рентгенологічною динамікою (ПЕТ/КТ від 11/04/2023). Підозра на наявність синхронної неоплазії шлунку (GIST?). Стан після EUS-FNA біопсії шлунку, core-біопсії печінки, гістологічно - гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST) шлунку, метастаз GIST в печінку (CSD). 08/2023 - стан після 4-х місяців лікування Іматинібом з вираженою позитивною радіологічною (ПЕТ/КТ) відповіддю. 03/2025 - стан після 2х років лікування Іматинібом з позитивною клінічною картиною. 05/2025 - стабільна радіологічна динаміка на тлі лікування Іматинібом.

Дані попередніх досліджень для порівняння: ПЕТ/КТ з ФДГ 13/05/2025, 14/03/2024

Методика дослідження: для ретроспективного аналізу надані дані ПЕТ/КТ з ФДГ 19/06/2026

Знахідки:

Голова та шия

Як і при попередній візуалізації, змін характерних для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено.

Без істотної динаміки з 13/05/2025, без появи нових активних чи суспектних уражень.

Грудна клітка

Як і при попередній візуалізації, змін характерних для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено.

Без істотної динаміки з 13/05/2025, без появи нових активних чи суспектних уражень.

Немає надлишкової плевральної та перикардіальної рідини, тромбів великих судин.



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

Живіт і таз

Відомі осередки та маси в печінці загалом сталими розмірами, втім пристінково в них, зокрема в найбільшій в правій частці є нові вузлоподібні елементи з помітним підсиленням та появою частково фокально помірно підвищеної активності, що помірно вища печінкового пулу, що найкраще помітно по вузлу 42 в лівій частці з аптейком до SUVmax 3.2 (паренхіма поруч SUV 2).

Нових окремих схожих активних чи суспектних вузлів не знайдено.

Відомі залишки пухлини з шлунку без істотної активності та вузол над сечовим міхуром/маткою праворуч також без істотної активності та без динаміки.

Нових окремих активних чи схожих вузлів, нової суспектної лімфаденопатії не знайдено.

Немає ознак кишкової непрохідності, асциту, гідронефрозу, розширення жовчних протоків, тромбів великих судин.

Кістки та м'які тканини

В голівці правої стегнової кістки нове видовжене/географічне розрідження кісткової речовини біля 31 мм із склеротичним контуром та помірною активністю, наразі без сплюснення/деформації голівки.

Інших нових активних/суспектних кісткових уражень не знайдено.

Радіологічний висновок:

В печінкових ураженнях нові пристінкові компоненти з помірною активністю, що є підозрою щодо повернення вітальних пухлинних елементів метастазів GIST.

Лікар:

Новіков М.Є.